



Prefeitura Municipal de São Carlos

CONCURSO PÚBLICO

13. PROVA OBJETIVA

MÉDICO – ÁREA MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA 1 HORA DO INÍCIO DA PROVA.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos



Prefeitura Municipal de
São Carlos

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01					
02					
03					
04					
05					

06					
07					
08					
09					
10					

11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					

21					
22					
23					
24					
25					

QUESTÃO	RESPOSTA				
26					
27					
28					
29					
30					

31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					

41					
42					
43					
44					
45					

46					
47					
48					
49					
50					

01. A criação do SUS na Constituição Federal de 1988

- (A) foi o resultado de um grande movimento sanitário mundial e brasileiro, que preconizava a necessidade de um sistema de saúde público e gratuito para a população mais desfavorecida social e economicamente.
- (B) foi resultado do movimento contrário à situação existente durante a ditadura militar, época em que havia um sistema universal e descentralizado, com grandes dificuldades de se impor por falta de financiamento adequado.
- (C) foi o resultado de um processo social em contraposição a um modelo assistencial privatista hegemônico anterior, que tinha como uma das características privilegiar a prática médica curativa e individual, em detrimento das ações coletivas.
- (D) representou a vitória do movimento sanitário que propunha um modelo de sistema de saúde universal e descentralizado, com enfoque coletivo e preventivo de pequena complexidade, mesmo que em detrimento das ações curativas e individuais.
- (E) representou a vitória do movimento sanitário, composto principalmente por médicos, que propunha importantes mudanças no tocante às responsabilidades dos gestores estaduais, aos quais foram passadas as execuções das principais ações de saúde coletiva e práticas curativas individuais.

02. A legislação referente ao SUS determina que

- (A) a sua gestão pode ser pública ou privada, dependendo da situação de cada estado da federação, devendo a decisão ser sempre submetida aos conselhos de saúde.
- (B) a sua gestão na esfera estadual pode ser exercida pelo Secretário de Saúde ou por um dos representantes da sociedade do Conselho Estadual de Saúde, desde que haja delegação formal de competência.
- (C) tanto a gestão como a gerência dos serviços que dele fazem parte devem ser exercidas por entes públicos, a não ser que haja uma deliberação em contrário do poder legislativo.
- (D) a sua gestão deve ser sempre pública, podendo a gerência dos serviços que dele fazem parte ser pública ou privada.
- (E) os conselhos de saúde, por serem as instâncias máximas em cada esfera de governo, podem deliberar sobre qualquer forma de gestão e de gerência dos serviços de saúde.

03. A vigilância sanitária de portos e aeroportos deve ser normatizada e executada por órgãos

- (A) municipais, exclusivamente.
- (B) federais, complementada por órgãos municipais e estaduais.
- (C) estaduais, exclusivamente.
- (D) municipais, complementada por órgãos estaduais.
- (E) estaduais, complementada por órgãos federais.

04. A evolução do SUS

- (A) tem evidenciado cada vez mais que os municípios bastam a si próprios, sendo a esfera estadual de governo dispensável para a sua consolidação, pois a execução atual das ações de saúde são totalmente municipalizadas.
- (B) tem mostrado como a regulação das referências já é um problema superado, o que dispensa o gestor da esfera estadual de governo dessa função, passando à atribuição de intermediar verbas de origem federal.
- (C) tem mostrado que as dificuldades de repor recursos humanos outrora existentes não mais existem, depois que a legislação passou a permitir a contratação de profissionais por meio das fundações estatais.
- (D) tem mostrado que a desmotivação dos trabalhadores da saúde pode ser facilmente superada por mecanismos de gerência na administração direta, que permitam a avaliação individual do desempenho.
- (E) tem evidenciado o papel do gestor da esfera estadual como coordenador em âmbito do estado e importante ator na consolidação da integralidade da atenção à saúde.

05. Há uma forte convicção por parte dos gestores do SUS de que os gastos públicos com a saúde, no país, são insuficientes para um sistema público universal. Esse problema poderá ser solucionado

- (A) se houver correção de distorções na vinculação de recursos da União e esclarecimento do que são ações e serviços de saúde.
- (B) se o governo federal publicar um decreto definindo mais fontes de recursos federais e municipais.
- (C) se houver um decreto federal que determine diferentes formas de gestão e gerenciamento de serviços.
- (D) se houver uma priorização das ações de saúde de baixa complexidade, sem o uso das tecnologias mais avançadas da investigação médica.
- (E) se houver uma parceria com o setor privado na gestão do sistema, aproveitando-se o acúmulo desse setor na agilização de resolução de problemas emergenciais.

06. O Pacto pela Saúde propõe que nos territórios

- (A) municipais se desenvolvam todas as ações e serviços de atenção primária à saúde, assim como de serviços especializados.
- (B) das macrorregiões de saúde haja serviços especializados de maior densidade tecnológica.
- (C) municipais se desenvolvam todas as ações de vigilância em saúde, das mais simples àquelas de grande complexidade.
- (D) municipais somente as ações emergenciais sejam desenvolvidas obrigatoriamente.
- (E) das microrregiões haja serviços conveniados com centros universitários de especialidades de maior densidade tecnológica.

07. Um trabalhador da construção civil sofre uma queda e sofre múltiplas fraturas. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) Todo o atendimento deve ser prestado por serviço conveniado com a empresa, não cabendo ao SUS assumir esse ônus.
- (B) O atendimento de urgência só pode ser feito em unidade que tenha um ortopedista.
- (C) O atendimento de urgência deve ser feito no município de ocorrência, mas caso seja necessária cirurgia, deve ser encaminhado a um serviço estadual.
- (D) O atendimento de urgência e acompanhamento devem ser feitos dentro da rotina da assistência ao paciente politraumatizado.
- (E) O atendimento de urgência deve ser feito no município de ocorrência, mas o acompanhamento deve ocorrer no município da empresa.

08. Em um município de pequeno porte, discute-se a formação do Conselho Municipal de Saúde. Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de municípios com menos de 20 mil habitantes, não há obrigatoriedade de se ter um Conselho de Saúde.
- (B) Nos casos de municípios com menos de 10 mil habitantes, o Conselho de Saúde pode ser substituído pela Câmara Municipal.
- (C) O Conselho Municipal de Saúde deve ser formado como em qualquer município, independentemente de suas dimensões.
- (D) Nos casos de municípios com menos de 10 mil habitantes, o Conselho Estadual de Saúde pode decidir as questões mais importantes.
- (E) O Conselho Municipal de Saúde pode ter uma composição diferente daquela prevista na Lei n.º 8.142/90.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

09. Avanços na tecnologia e no cuidado médico permitiram que a visita domiciliar tenha adquirido grande impacto nos programas de saúde da família. Nesse contexto, são procedimentos importantes para o médico de família:

- (A) antibioticoterapia parenteral, transfusão e nutrição domiciliar (enteral e parenteral).
- (B) cirurgias mais complexas, diálise peritoneal e dispositivos de circulação assistida.
- (C) diálise peritoneal, cuidados aos grandes queimados e tratamento antimicrobiano.
- (D) cuidados com escaras, assistência a pacientes terminais e traqueostomia.
- (E) terapia respiratória, quimioterapia e radioterapia.

10. Mulher de 37 anos relata cefaleia persistente há 15 anos. Ela fala que sempre que a “pressão está aumentada”, ela tem cefaleia. Ao exame físico: pressão arterial: 170 x 105 mmHg, pulso = 88 bpm, temperatura = 36,2 °C; ausculta cardíaca e pulmonar normais; exame neurológico normal. Os valores pressóricos persistem elevados em várias outras medidas, inclusive, meses após. Admitindo-se que não haja qualquer contraindicação medicamentosa e que todos os exames laboratoriais sejam normais, em relação à pressão arterial, a prescrição de primeira escolha é com

- (A) clortalidona.
- (B) captopril.
- (C) losartana.
- (D) nifedipino.
- (E) propranolol.

11. Nos casos de gastroenterite na infância, é correto afirmar que

- (A) a reposição salina endovenosa é a mais eficaz, sendo a primeira escolha.
- (B) deve-se retardar o máximo possível a realimentação, devido ao risco de exacerbar a diarreia.
- (C) exames complementares devem ser colhidos nos casos leves, moderados e graves, sobretudo pelo impacto que o resultado pode ter na comunidade.
- (D) a terapia de hidratação oral pode ser realizada no posto de saúde ou mesmo em domicílio, sendo, na maioria das vezes, o item mais importante do tratamento.
- (E) a administração precoce de antibiótico não deve ser esquecida, pois se associa à redução dos casos de sepse grave ou mesmo choque séptico.

12. Homem de 59 anos, antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e *diabetes mellitus*, procura o médico para mostrar o resultado dos exames que realizou no último mês. Ao exame físico: peso = 80 kg, IMC = 33 kg/m². Exames: glicemia de jejum: 118 mg/dL, ureia = 36 mg/dL, creatinina = 1,8 mg/dL; urina tipo 1: proteínas (2+/4+), leucócitos = 5/campo e hemáceas = 1/campo; perfil lipídico: colesterol total = 286 mg/dL, HDL = 36 mg/dL, LDL = 198 mg/dL e triglicérides = 142 mg/dL. Nesse momento, é correto prescrever
- (A) atorvastatina e bezafibrato.
 - (B) sinvastatina e bezafibrato.
 - (C) dieta e niacina.
 - (D) dieta, indicar exercícios físicos e repetir a dosagem sérica do perfil lipídico em 6 meses.
 - (E) dieta, indicar exercícios físicos e sinvastatina.
13. São os agentes etiológicos mais frequentes de meningite bacteriana, no período neonatal:
- (A) bacilos gram-negativos, vírus herpes e listeria.
 - (B) listeria, estreptococo e *E. Coli*.
 - (C) meningococo, pneumococo e bacilos gram-negativos.
 - (D) pneumococo, klebsiela e *E. Coli*.
 - (E) hemófilos, pseudomonas e estafilococo.
14. Mulher de 19 anos, casada, 2 filhos, foi doar sangue e dez dias após recebeu uma carta contendo resultados de exames realizados pela unidade hematológica. Ela negou uso de drogas injetáveis, transfusão de hemoderivados ou relação sexual sem preservativo. Resultados para hepatite B: HbsAg: negativo, anti-Hbs: negativo, HbeAg: negativo, anti-Hbe: negativo, anti-Hbc total positivo e anti-Hbc-IgM: negativo. Com essas informações, é correto afirmar que ela
- (A) teve hepatite B há muitos anos e está curada.
 - (B) teve hepatite B recentemente e está curada.
 - (C) deve tomar a vacina para hepatite B, em três doses.
 - (D) está com hepatite B aguda e deve ser encaminhada ao hospital.
 - (E) provavelmente tomou a vacina para hepatite B e está protegida.
15. Em relação aos hipoglicemiantes orais, é correto afirmar que
- (A) a nateglinida atua nos receptores nucleares, aumentando a síntese de transportadores de glicose.
 - (B) a metformina tem ação pancreática, aumentando a secreção de insulina.
 - (C) os análogos das glitazonas podem ocasionar retenção de líquido, ganho de peso e piora do perfil lipídico.
 - (D) a acarbose tem ação intestinal e reduz, em níveis absolutos, até 4 pontos percentuais a hemoglobina glicada.
 - (E) a glicazida atua prioritariamente no fígado, diminuindo a gliconeogênese.
16. Durante uma consulta periódica, uma mulher relatou seu desconforto frente à atitude do marido de persistir fumando cigarros dentro de casa (cerca de 15 cigarros ao dia). Em relação ao tabagismo passivo, é correto afirmar que
- (A) a quantidade de cigarros consumidos pelo marido é incapaz de causar alterações significativas na paciente.
 - (B) acarreta maior risco para a família se o cigarro usado pelo marido não tiver filtro.
 - (C) a espirometria está indicada e pode diagnosticar doença pulmonar obstrutiva crônica na mulher.
 - (D) a espirometria está indicada e mesmo que ela seja normal, clinicamente a mulher tem doença pulmonar obstrutiva crônica pela exposição.
 - (E) diferente do tabagismo ativo, que causa inúmeros males à saúde, o tabagismo passivo não está associado à doença cardiovascular ou pulmonar.
17. Admitindo-se que um paciente não tenha qualquer contraindicação ao ácido acetilsalicílico, baseado em estudos de adequado rigor epidemiológico, é correto prescrevê-lo como profilaxia primária de doença cardiovascular:
- (A) homem de 26 anos e obesidade mórbida.
 - (B) homem de 56 anos com hipertensão arterial sistêmica e *diabetes mellitus*.
 - (C) mulher de 67 anos com história de infarto agudo do miocárdio há 2 anos.
 - (D) mulher de 43 anos e tabagismo (10 cigarros ao dia).
 - (E) mulher de 89 anos, com síndrome demencial.
18. Em relação ao sangramento transvaginal no primeiro trimestre da gravidez, é possível afirmar que a causa mais frequente é
- (A) a cervicite aguda.
 - (B) a doença trofoblástica gestacional.
 - (C) a placenta prévia.
 - (D) o abortamento.
 - (E) o descolamento prematuro da placenta.
19. Mulher de 61 anos, acompanhada regularmente, encontra-se preocupada com o seu risco de câncer. Ela negou doenças prévias, tabagismo, etilismo e não faz uso de quaisquer medicações. Nega também que tenha arma de fogo em casa. É casada e mãe de seis filhos. Exame físico normal, mas com aparente ansiedade, sem indícios de depressão. Com relação ao rastreamento do câncer (*screening*), além de indicar a mamografia e o exame de Papanicolau, recomenda-se, também,
- (A) pesquisa de sangue oculto nas fezes.
 - (B) tomografia de tórax.
 - (C) ultrassonografia transvaginal.
 - (D) dosagem sérica de marcadores tumorais.
 - (E) endoscopia digestiva alta.

20. Uma das obrigações mais importantes dos médicos de família é a utilização de todos os recursos que a medicina tem para a melhoria de saúde do paciente e da comunidade. Por isso, algumas vezes, necessita-se de consulta com especialistas de outras áreas. Nesse aspecto, é correto afirmar que

- (A) avaliações informais são tão ou mais importantes que as formais.
- (B) a seleção do consultor mais adequado para as necessidades da pessoa constitui um aspecto importante e de responsabilidade do médico de família.
- (C) caso o consultor faça uma recomendação com a qual o médico de família não concorde, ele deve segui-la, pois o consultor tem mais experiência e conhecimento.
- (D) o encaminhamento deve ser sucinto, direto e prático para que o consultor não perca tempo e possa resolver de uma vez o problema.
- (E) quando o consultor for um psiquiatra, deve-se deixar claro que a primeira opção do médico de família é não prescrever qualquer psicotrópico.

21. Com relação ao rastreamento do câncer, é correto afirmar que

- (A) o exame clínico das mamas tem altíssima sensibilidade no rastreamento do câncer de mama.
- (B) o exame digital do reto é a medida de maior impacto no rastreamento do câncer de cólon e reto.
- (C) a dosagem sérica do antígeno prostático (PSA) tem altíssima sensibilidade com método de rastreamento de câncer de próstata.
- (D) a principal forma de rastreamento do câncer de pele é feita através da medição diária dos valores de UVA.
- (E) a estratégia de maior impacto no rastreamento do câncer de colo uterino é a realização da citologia oncológica de forma periódica.

22. Homem de 38 anos, previamente hígido, procura o médico no posto de saúde para mostrar uma radiografia de tórax realizada há uma semana. Ele nega quaisquer queixas e fez a radiografia porque seu vizinho diagnosticou um câncer de pulmão dessa maneira. Exame físico: normal. Nesse momento, como atividade de promoção à saúde, a conduta correta é



- (A) indicar nova radiografia em seis meses.
- (B) solicitar tomografia de tórax.
- (C) solicitar a dosagem sérica do antígeno prostático (PSA).
- (D) solicitar glicemia de jejum e perfil lipídico.
- (E) pedir sangue oculto nas fezes.

23. São dois pontos cruciais, prioritários e mais importantes para o médico de família ao avaliar uma criança com quadro clínico de pneumonia comunitária:

- (A) colher exames de sangue/ sorologias e indicar internação hospitalar.
- (B) colher dados com a família sobre as comorbidades e notificar o hospital mais próximo.
- (C) avaliar todos os familiares para a possibilidade de tuberculose e iniciar o tratamento antimicrobiano.
- (D) avaliar se a criança pode ser tratada em domicílio e iniciar o tratamento empírico correto.
- (E) visitar o domicílio para avaliar as condições de tratamento e colher exames de sangue.

24. Constitui a complicação mais frequentes da otite média aguda na infância:

- (A) mastoidite aguda.
- (B) abscesso de Bezold.
- (C) tromboflebite de seios venosos.
- (D) labirintite infecciosa.
- (E) abscesso cerebral.

25. Admitindo-se que não exista uma contraindicação, o tratamento correto da vaginite por *Trichomonas vaginalis* pode ser feito com

- (A) albendazol.
- (B) benzonidazol.
- (C) tinidazol.
- (D) praziquantel.
- (E) cambendazol.

26. Durante uma visita domiciliar, o médico observa a seguinte alteração na região cervical de uma paciente.



Com essa informação, é correto

- (A) fazer observação semestral e biópsia, se não regredir.
- (B) fazer observação anual e biópsia, se não regredir.
- (C) indicar uma biópsia apenas se houver crescimento.
- (D) indicar uma biópsia aspirativa com agulha fina.
- (E) solicitar ultrassonografia de tireoide e só indicar biópsia se ela sugerir malignidade.

27. O quadro clínico mais frequente de endometrite puerperal é de
- (A) dor à palpação das fossas ilíacas, febre alta, calafrios, hipotensão e confusão mental.
 - (B) febre, dor abdominal, loquiação fétida, útero doloroso e amolecido.
 - (C) útero que não involui, amolecido, doloroso e febre sem origem aparente.
 - (D) loquiação fétida, dor abdominal unilateral e sinais de peritonismo.
 - (E) síndrome da resposta inflamatória sistêmica, corrimento vaginal, útero firme e doloroso.
28. Paciente de 27 anos, sem quaisquer antecedentes, com quadro de tosse, febre e expectoração há 3 dias, apresenta a radiografia de tórax reproduzida a seguir. Exame físico: consciente, temperatura: 38,1 °C, pulso: 96 bpm, frequência respiratória: 16 ipm e pressão arterial: 110 x 70 mmHg. É correto



- (A) encaminhá-lo ao hospital para realizar coleta de exames de sangue.
 - (B) encaminhá-lo ao hospital para receber uma dose endovenosa de antibiótico.
 - (C) prescrever ciprofloxacino e só encaminhá-lo ao hospital de não houver melhora em 72 horas.
 - (D) prescrever penicilina procaína intramuscular e reavaliar o paciente em uma semana.
 - (E) prescrever claritromicina por via oral e reavaliar o paciente em 72 horas.
29. Criança de 7 anos retorna ao posto de saúde pra checar o resultado dos exames de sangue. Hemoglobina: 10,6 g/dL, VCM: 67 fL, leucócitos: 9 860/mm³ (diferencial normal) e plaquetas: 286 000/mm³; reticulócitos: 0,7%; ferro sérico: 12 mcg/dL (normal: 150 a 250); índice de saturação da transferrina: 8% (normal: 20 a 40) e capacidade total de ligação de ferro: 486 mcg/dL (normal: 200 a 350). A conduta correta é
- (A) prescrever ferro oral, orientar a dieta e solicitar parasitológico de fezes.
 - (B) prescrever ferro oral, ácido fólico e vitaminas do complexo B e C.
 - (C) solicitar mielograma e descartar leucemia aguda.
 - (D) solicitar haptoglobina sérica e perfil hemolítico.
 - (E) prescrever ferro oral e solicitar avaliação do serviço de proteção à criança.

30. Criança de 11 anos retorna à consulta no posto de saúde devido a crises de broncoespasmo diurnas, quase que diariamente, e cerca de uma a duas vezes por semana, pela madrugada. Refere uso de um a dois frascos de fenoterol inalatório por mês. Exame físico: sibilos discretos bilaterais (melhorou após uma inalação). Realizado um pico de fluxo expiratório que foi de 70% do previsto. Nesse momento, o tratamento inicial de 1.^a escolha é
- (A) β_2 -agonista inalatório e corticoide oral quando necessário.
 - (B) β_2 -agonista inalatório e corticoide inalatório por tempo indefinido.
 - (C) corticoide oral por 7 dias e corticoide inalatório por tempo indefinido.
 - (D) corticoide oral por 14 dias, corticoide inalatório e β_2 -agonista de longa ação inalatório, ambos por tempo indefinido.
 - (E) corticoide oral, corticoide inalatório e β_2 -agonista de longa ação inalatório, todos por tempo indefinido.
31. Mulher de 28 anos desmaiou durante a espera por uma consulta no posto de saúde. Após acordar, ela relatou que estava com calor, em ortostase, e de repente teve uma tontura e desmaiou. Cerca de 1 minuto após, ela recobrou a consciência. Glicemia capilar: 72 mg/dL. Exame físico: corada, hidratada, afebril; Glasgow: 15, pressão arterial: 100 x 60 mmHg, pulso: 68 bpm, SatO₂: 95%; ausculta cardíaca, pulmonar e exame neurológico: normais. Eletrocardiograma: normal. Em relação à principal hipótese diagnóstica, é correto afirmar:
- (A) ataque isquêmico transitório e acidente vascular cerebral são causas frequentes da síndrome descrita.
 - (B) exames laboratoriais são frequentemente úteis para detecção da etiologia do quadro descrito.
 - (C) o ecocardiograma é essencial para a correta estratificação do quadro.
 - (D) movimentos tônicos-clônicos breves (< 10 segundos) podem ocorrer como manifestação associada do quadro.
 - (E) prolongamento do intervalo QRS (> 0,12 segundos) no eletrocardiograma não indica gravidade.
32. Mulher, 37 anos de idade, procurou o posto de saúde referindo taquicardia, dispnéia, sensação de morte, desânimo, fadiga, irritabilidade, choro fácil e insônia. Relatou que não tem mais vontade de trabalhar. Exame físico: PA: 170 x 40 mmHg; FC: 128 bpm; ausculta cardíaca e pulmonar: normais; extremidades: tremor espontâneo importante com sudorese. Nesse momento, é correto
- (A) prescrever um antidepressivo tricíclico e marcar um retorno para 15 dias.
 - (B) prescrever um antidepressivo serotoninérgico e marcar um retorno para 4 semanas.
 - (C) encaminhar para terapia de grupo e seguimento com psicólogo.
 - (D) considerar que, provavelmente, trata-se de uso de drogas ilícitas.
 - (E) solicitar exames gerais e hormônios tireoidianos (T4 livre e TSH).

33. Em relação à epiglottite aguda na infância, é correto afirmar:
- (A) diferente das infecções invasivas, como a meningite, não houve redução da sua incidência com a vacinação.
 - (B) a etiologia viral é a mais frequente.
 - (C) o diagnóstico deve ser confirmado através da sorologia, pois tem grande impacto populacional e na prevenção de surto na comunidade.
 - (D) os achados mais frequentes são febre alta, rinorreia e obstrução nasal.
 - (E) salivação e estridor são achados de obstrução iminente de vias aéreas.
34. Dentre as causas de cefaleia que são importantes para o médico de família, é correto afirmar:
- (A) a migrânea (enxaqueca) é sugerida pelo quadro clínico, embora haja a necessidade de avaliação formal de um neurologista.
 - (B) alívio da dor com dipirona descarta que a etiologia é vascular.
 - (C) a intensidade da dor de cabeça não se correlaciona necessariamente com a sua gravidade.
 - (D) a ausência de aura torna a enxaqueca uma causa improvável para a cefaleia.
 - (E) caso os sintomas do paciente sejam crônicos, recomenda-se realizar tomografia de crânio.
35. Na abordagem de quadros de fadiga na comunidade, são achados que sugerem etiologia psíquica (depressão):
- (A) idade muito avançada quando do início.
 - (B) caráter agudo dos sintomas (dias).
 - (C) caráter crônico dos sintomas (meses).
 - (D) piora da fadiga durante o exercício físico.
 - (E) exame neurológico alterado.
36. No âmbito da saúde comunitária, os principais e mais importantes fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica são:
- (A) obesidade, história familiar positiva e dieta rica em sal.
 - (B) tabagismo, diabetes e dislipidemia familiar.
 - (C) doença endocrinológica, etilismo e sedentarismo.
 - (D) estresse emocional, sedentarismo e tabagismo.
 - (E) uso de anti-inflamatórios, etilismo e perda da função renal.
37. A causa mais comum de anemia aguda em pacientes pediátricos é
- (A) alergia a derivados do leite.
 - (B) crise de anemia falciforme.
 - (C) deficiência nutricional.
 - (D) hemorragia.
 - (E) hemoglobinopatia.
38. Em relação à hipertensão arterial sistêmica, no âmbito da saúde comunitária, a que tem maior impacto como adjuvante no controle pressórico é
- (A) redução do tabagismo.
 - (B) restrição do sal.
 - (C) aumento do tempo de lazer.
 - (D) dieta rica em fibras.
 - (E) suplemento vitamínico.
39. Existem várias razões pelas quais a família tem grande importância na saúde e na doença do ponto de vista comunitário. Dentre elas, é correto afirmar que
- (A) a família é essencial para o desenvolvimento infantil.
 - (B) doenças são mais facilmente diagnosticadas em famílias numerosas.
 - (C) a interação genética sofre menor influência ambiental.
 - (D) as orientações transmitidas pelo profissional de saúde disseminam-se na comunidade com imensa facilidade.
 - (E) padrões genéticos se repetem, tornando o diagnóstico presuntivo confiável.
40. Mulher de 23 anos procura o posto de saúde devido a grande insistência da mãe. Ao exame ginecológico, encontrou-se a imagem descrita a seguir.



O diagnóstico correto é de

- (A) carcinoma espinocelular.
- (B) condiloma.
- (C) elefantíase vulvar.
- (D) linfogranuloma venéreo.
- (E) sífilis.

41. Febre persistente no neonato, sem foco infeccioso aparente, pode aumentar o risco de evolução para doença bacteriana grave e sepse. Dentre as bactérias que podem causar sepse nessa faixa etária, são as mais frequentes
- (A) bacilos gram-negativos e listeria.
 - (B) estafilococo e listeria.
 - (C) estafilococo e estreptococo.
 - (D) estreptococo e bacilos gram-negativos.
 - (E) pseudomonas e hemófilos.
42. Em relação aos princípios para criação e aplicação de programas de triagem e descoberta de caso na comunidade, constitui um de grande importância:
- (A) a doença em questão deve ser um problema sério de saúde.
 - (B) a fase sintomática deve ser muito longa.
 - (C) deve incorporar no máximo um exame por doença, de grande sensibilidade e grande especificidade.
 - (D) o tratamento deve gerar taxas de cura acima de 95%.
 - (E) a incorporação de exames de alta tecnologia.
43. Alguns princípios devem ser seguidos quando se planeja aplicar métodos preventivos na medicina de família e comunidade. Nesse aspecto, é correto afirmar que
- (A) o exame físico completo anualmente oferece a melhor ferramenta disponível.
 - (B) registros eletrônicos, computadores e internet não devem ser incorporados nessa estratégia.
 - (C) o exame periódico de saúde oferece uma estratégia racional sobretudo quando exames e procedimentos são repetidos a intervalos determinados por evidências epidemiológicas.
 - (D) as probabilidades estatísticas não devem ser aplicadas a uma pessoa individualmente.
 - (E) as recomendações não devem e não podem ser feitas caso o indivíduo não esteja receptivo.
44. Muitos aspectos da avaliação clínica são os mesmos se realizados em um posto de saúde, no hospital ou na residência do paciente. Entretanto, na visita domiciliar, algumas informações são de grande importância e únicas. Dentre elas, destaca-se
- (A) avaliar a renda média e a probabilidade de que o paciente possa pagar os remédios prescritos.
 - (B) conseguir provar que o paciente tem dado informações equivocadas e mentirosas da sua condição clínica.
 - (C) detectar os perigos e riscos na residência, como exemplo, o risco de queda (tapete, escada e piso liso).
 - (D) diagnosticar situações associadas ao risco cardiovascular global.
 - (E) entrevistar vizinhos, amigos e conhecidos.
45. Numa consulta no posto de saúde, paciente sem qualquer comorbidade, o tratamento de escolha da lesão descrita na figura é mais bem feito com
- 
- (A) amoxicilina.
 - (B) cefalexina.
 - (C) doxiciclina.
 - (D) penicilina.
 - (E) vancomicina.
46. Em relação à infecção do trato urinário de recém-nascidos, é correto afirmar que
- (A) acomete muito mais frequentemente o sexo feminino.
 - (B) é causada por infecção ascendente originada do trato urinário baixo.
 - (C) febre é muito comum e ocorre em mais de 90% dos casos.
 - (D) hematúria e urina fétida são comuns e ajudam na suspeita diagnóstica.
 - (E) os sintomas podem ser inespecíficos e incluem inquietação, choro e letargia.

47. São causas precipitantes mais frequentes de crises epiléticas agudas sintomáticas em crianças:
- (A) distúrbio eletrolítico e sepse.
 - (B) febre e infecção.
 - (C) meningite e infecção urinária.
 - (D) vacinação recente e trauma.
 - (E) uso de medicamentos e anomalia estrutural do sistema nervoso central.
48. As principais etiologias da bronquiolite aguda na criança são:
- (A) adenovírus e vírus influenza.
 - (B) influenza vírus e parainfluenza.
 - (C) vírus sincicial respiratório e influenza vírus.
 - (D) vírus parainfluenza e coxsackie.
 - (E) vírus sincicial respiratório e rinovírus.
49. Em relação à dor, pode-se afirmar que
- (A) a etiologia da dor é altamente correlacionada com a sua intensidade.
 - (B) escalas numéricas não se mostraram úteis na avaliação da intensidade da dor.
 - (C) não deve ser desvalorizada pelo médico de família e pode indicar distúrbio psiquiátrico de base.
 - (D) não se deve confiar na intensidade da dor descrita pelo paciente.
 - (E) só deve ser tratada quando a etiologia for esclarecida.
50. Em relação à doença cardiovascular, constitui um dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica (plurimetabólica):
- (A) colesterol HDL < 65 mg/dL.
 - (B) doença coronariana multiarterial.
 - (C) glicemia de jejum > 180 mg/dL.
 - (D) índice de massa corpórea ≥ 30 kg/m².
 - (E) triglicerídios > 400 mg/dL.